

Ileal Conduit (Bricker)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pagpapalabas ng ihi sa pamamagitan ng stoma bag

Ang ileal conduit (Bricker) ay isang paraan upang mapalabas ang ihi pagkatapos matanggal o huminto ang pantog. Gumagamit ang siruhano ng maikling piraso ng bituka upang dalhin ang ihi mula sa mga bato patungo sa isang maliit na bukas sa tiyan (stoma), kung saan ito ay dumadaloy sa isang magaang na ostomy bag na isinusuot ninyo. Ito ang pinakasimple at pinakakaraniwang uri ng urinary diversion.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Isang **6–8 pulgadang piraso ng maliit na bituka** ang ginagamit bilang **daluyan** — hindi ito nag-iimbak ng ihi. Ang mga ureter (ang mga tubo mula sa mga bato) ay ikinokonekta dito, at ang isang dulo ay inilalabas sa balat bilang isang **stoma**, kadalasan sa ibabang-kanang bahagi ng tiyan. Dahil patuloy na lumalabas ang ihi, isinusuot ninyo ang isang magaang na pouch (**ostomy bag**) sa ibabaw ng stoma na ibinubuhos nang ilang beses sa araw at pinapalitan tuwing ilang araw.

- **Walang kailangang kontrolin at walang catheter na gagamitin.**
- Ang natitirang bituka ay **muling ikinokonekta** upang normal na mapatuloy ang pagtunaw ng pagkain.
- Ang isang **ostomy nurse** ay magtuturo sa inyo kung paano alagaan ang stoma at bag.

Ligtas Ba Ito?

Ang ileal conduit ay naging pamantayan ng incontinent na urinary diversion sa loob ng mahigit 70 taon — ito ang pinakasimple, na may pinakamaikling operasyon. Tulad ng anumang malaking operasyon, may panganib ito (pagdurugo, impeksiyon, tagas sa pinagsamang bahagi ng bituka o ureter). Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ang ilan ng problema sa stoma o balat, impeksiyon sa ihi (UTI), o pagbabago sa asin at bitamina — lahat ay sinisiguradong matukoy sa follow-up.

MGA TERMINO

Urinary diversion

Bagong landas para makalabas ang ihi kapag nawala o hindi na gumagana ang pantog.

Ileal conduit

Maikling piraso ng maliit na bituka na nagdadala ng ihi patungo sa stoma.

Stoma

Ang maliit na bukas sa tiyan, gawa mula sa bituka, kung saan lumalabas ang ihi.

Ostomy bag

Ang pouch (appliance) na isinusuot sa ibabaw ng stoma upang mangolekta ng ihi.

Mga ureter

Ang mga tubo na nagdadala ng ihi mula sa mga bato; ikinokonekta ang mga ito sa conduit.

Ostomy nurse

Nurse na nagmamarka ng pinakamainam na lugar para sa stoma at nagtuturo ng pag-aalaga nito.

Mucus

Malagkit na likido na ginagawa ng bituka; normal ang makitang higot nito sa ihi.

Peristomal skin

Ang balat sa paligid ng stoma na kailangang malinis at nakaprotektahan.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, asahan ang sakit ng tiyan, at ilang araw bago “gumising” ang bituka. Walang pakiramdam ang stoma mismo. Nananatili sa ospital nang mga 5–7 araw.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang tagubilin bago mag-opera (pag-aayuno, gamot na ihihint, kasama ang blood thinners). Maaaring may **bowel prep** din.
- Makipagkita sa **ostomy nurse**, na magmamarka ng pinakamainam na lugar para sa stoma — mahalaga para sa komportable, hindi tumatagas na fit.
- Huwag manigarilyo** — nagpapabagal ito ng paghilom — at mag-ayos ng tulong sa bahay pagkatapos.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o mayroon na kasalukuyang impeksiyon
- May **sakit sa bituka** (tulad ng Crohn’s o colitis) o naoperahan na ang tiyan o nairadyasyon dati

Ano ang Nangyayari Habang Isinasagawa ang Operasyon

- 1 Natutulog kayo sa ilalim ng anesthesia at binibigyan ng antibiotics.
- 2 Inihihiwalay ang isang maikling piraso ng bituka at muling ikinokonekta ang natitirang bahagi.
- 3 Ang mga ureter ay ikinokonekta sa piraso ng bituka.
- 4 Ang isang dulo ay inilalabas sa tiyan bilang stoma; inilalagay ang malambot na stents at drain habang ito ay gumagaling.

Pagkatapos ng Operasyon

- Uuwi kayo pagkatapos ng mga **5–7 araw**. Ituturo ng ostomy nurse kung paano **ubusin ang bag** (ilang beses sa araw) at **palitan ang appliance**.
- Normal ang **mucus** sa ihi. **Uminom ng maraming likido** at alagaan ang balat sa paligid ng stoma.
- Iwasang mag-angat ng mabigat nang mga 6 na linggo**. May panghabambuhay na check-up (kidney function, bitamina B12).

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Ang stoma ay **lumitim, pumula-pula, o bumawas**
- Kaunti o walang ihi** sa bag sa loob ng ilang oras
- Matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, o **walang gas o dumi** (hindi gumagalaw ang bituka)
- Matinding pagdurugo, o pamumula o may tagas ang sugat

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Gumagamit ang ileal conduit ng maikling piraso ng bituka para dalhin ang ihi sa stoma sa tiyan, papunta sa bag — ang pinakasimpleng diversion, walang catheter.
2. Para maghanda: pag-aayuno at bowel prep, makipagkita sa ostomy nurse para sa stoma marking, huwag manigarilyo, mag-ayos ng tulong.
3. Normal ang mucus sa ihi; ituturo ng ostomy nurse ang pag-aalaga ng bag at balat.